

NOTULEN

HARI / TANGGAL : JUMAT / 14 FEBRUARI 2025
PUKUL : 09:00 – SELESAI
JENIS MEETING : PRESENTASI LAPORAN HASIL SO JANUARI 2025
TEMPAT : LOKASI DINAS MASING - MASING (ZOOM MEETING)

Berikut hasil notulen :

No	Penjelasan
1	Pokok Bahasan : Selisih SO Masalah : - Selisih SO PHS Depo +9,709,300 Gudang 0 IKO Rp +2.236.466 - Selisih SO PHM Depo +357.772 Gudang -75.000 IKO Rp -55.954 Keterangan : A. PHS - Adanya permasalahan perhitungan jumlah fisik sediaan farmasi antara pagi dan malam berbeda, menjadi salah satu peluang ketidaksesuaian jumlah perhitungan SO yang dilaporkan dan menjadikan selisih hasil SO - Retur racikan / oplosan menjadi faktor selisih hasil SO, apakah alur permintaan obat racikan / oplosan sudah sesuai antara PHM dan PHS Tambahan: jika PHM yang menyiapkan racikan / oplosan shift malam, sebelum melakukan oplosan obat selalu konfirmasi kepada perawat untuk memastikan jenis obat, sehingga pagi ketika memberikan obat ke ruangan sudah pasti digunakan, dan dapat meminimalisir case obat terlanjur di oplos, namun pagi nya pasien rencana KRS. - Kesalahan auditor saat validasi, ditemukan case pada depo farmasi ketika auditor melakukan validasi pada sediaan yang sama tetapi master barang berbeda - Barang – barang antibiotik mengalami selisih lebih, setelah ditelusuri ternyata sebagian besar penyebabnya adalah perawat yang menggunakan obat pasien lain yang bersifat sharing dose, sehingga tidak sesuai antara obat yang digunakan dan obat yang di input B. PHM - Kontroling di PHM dalam menurunkan selisih hasil SO Farmasi - Analisis terjadinya Retur barang dari ruangan yang belum melakukan inputan di SIMRS - Perbaikan melalui BA atas ketidaksiplinan pelaksana di unit – unit dan dilaporkan kepada Kabid, apakah terdeteksi adanya adjusment stock yang dilakukan oleh RS PH Malang? Jika terdeteksi apakah sudah diketahui dan divalidasi tim auditor PT? Bagaimana keakuratan datanya? - Temuan di lapangan adanya case barang yang tidak di retur secara SIMRS, tetapi perawat menyerahkan obat kepada depo farmasi, petugas depo farmasi tidak croscek dengan SIMRS dan langsung menerima retur tersebut menjadi penyumbang selisih SO

	PIC :
	1. Kains Farmasi 2. Kabid. Penunjang
	Tindak Lanjut
	A. PHS 1. Memastikan perhitungan sesuai dengan memberikan tanggung jawab jumlah stock kepada PJ rak dan memploting jadwal staff farmasi yang mengikuti SO adalah PJ rak, sehingga memudahkan telusur selisih hasil SO ketika verifikasi dengan Auditor 2. Alur konfirmasi kepada perawat ditegaskan kembali sehingga ketika apoteker melakukan oplos obat dipastikan digunakan 3. Unit farmasi RS PH Sukorejo membuat penamaan kode unik dan diajukan ke pengadaan PT, sehingga memudahkan auditor dan unit farmasi ketika melakukan input penerimaan barang, input SO, dan dapat menjadi solutif terkait permasalahan salah input barang dengan kemiripan master barang B. PHM 1. Melakukan random stock 2. Kains Farmasi lebih ketat dalam telusur kepada unit2 dengan adanya obat2 an tidak bertuan 3. Retur barang dilakukan kepada depo farmasi sebelum pasien KRS 4. Temuan yang dilakukan setelah pasien KRS dilakukan retur ke gudang retur, dengan BA yang divalidasi oleh keuangan PT 5. Retur barang atas temuan diunit2 atas ketidaksiplinan SDM tidak boleh dilakukan ke depo farmasi 6. Evaluasi fitur Farmasi penerimaan Lainnya apakah dipertahankan dengan pertimbangan apa? Dan apakah di non aktifkan?
2	Pokok Bahasan : Obat Near ED
	Masalah :
	1. Tindak lanjut terhadap barang near ED dalam 6 bulan kedepan
	Keterangan :
	1. Adanya obat – obatan yang near ED di bulan Februari 2025
	PIC :
	1. Kains Farmasi 2. Kabid. Penunjang
	Tindak Lanjut
	1. Sediaan farmasi yang ED dalam bulan Februari sudah di serahkan ke Gudang farmasi untuk menunggu pengambilan barang dari pihak distributor 2. Kains Farmasi RS dan pengadaan PT sudah menindaklanjuti barang near ED sampai dengan April 2025 untuk di tukar dengan ED jauh dengan distributor farmasi 3. Tindak Lanjut jika distributor tidak dapat menukarkan barang dengan ED jauh adalah membeli Kembali barang ED dengan pembuatan retur barang dan mengurangi tagihan faktur 4. Kains Farmasi koordinasi dengan klinik Mutiara sehat dan antar RS jika di salah satu tempat menggunakan barang near ED maka akan melakukan penjualan barang antar unit usaha, sehingga barang Near ED dapat digunakan

	Tanggapan Komisaris PT – dr. M Endi 1. Perlakuan obat adalah inabler artinya jika pasien diberikan obat/ RS memberikan obat kepada pasien, maka bisa diajukan klaim tagihan ke pihak ke – 3 dan RS mendapatkan uang atas pelayanan pasien 2. Melakukan adjustment harian, apakah masih bisa dipercayai / valid hasil SO yang dilakukan per bulan? Tindakan ini apakah mengkontaminasikan data SO 3. Target SO tidak surplus / minus, tetapi target hasil SO adalah sesuai = equal 4. Hasil SO PHS secara grafik sudah konsisten > evaluasi dari bulan September ke januari apakah ada intervensi yang dilakukan dan memberikan hasil. 5. Hasil SO PHM secara grafik belum konsisten dan belum terpola 6. Random stock yang ada di pemimpin PHS dan PHM praktek nya tidak sama > dibuatkan rapat yang lebih teknis 7. Dilakukan audit sistem > kedatangan unit yang bersangkutan > audit secara offline 8. DEPO tidak ada hak untuk menerima barang, jika dilakukan penerimaan barang melalui GUDANG, jika tidak patuh dalam alur tersebut kesalahan akan tampak pada depo Tanggapan Direktur PT – dr. Sefrina 1. Jenis obat yang memiliki kemiripan penamaan mohon segera diajukan ke PT agar segera dilakukan update penamaan item agar sesuai dalam penginputan 2. Pasien yang moving dari IGD ke IRNA dibuatkan kebijakan agar pasien sebelum moving sudah diselesaikan
3	Pokok Bahasan : Closing Statement dari Komisaris Utama PT. Disa Prima Medika Keterangan : 1. Gambaran RS di tahun 2025 target mendapatkan omset sesuai yang ditentukan dan Laba sebelum pajak minimal 25% 2. Di Era BPJS Kesehatan pendapatan sudah ditentukan oleh pasien yang ditangani 3. Penjualan obat bukan pendapatan, semakin banyak belanja obat semakin memperbesar pengeluaran 4. Kabid, Karu dan Kains membantu menekan belanja obat yang terlalu besar pada obat – obatan jenis slow moving 5. Tidak ada belanja obat yang harganya lebih mahal, pengadaan dan direktur PT mencari substitusi obat yang harganya lebih rendah 6. Berita acara perlu dibuat dan dilaporkan kepada keuangan PT sebagai bentuk tanggung jawab RS untuk kontroling persediaan farmasi 7. Membenarkan adanya inputan sharing dose (stock keluar 1 > digunakan untuk beberapa pasien > inputkan 1 pcs di billing pasien) membantu meningkatkan pendapatan dan temuan atas sisa obat / BMHP dibuatkan Berita Acara untuk catatan dan diketahui auditor.

Pemimpin Rapat
Direktur PT Disa Prima Medika



(dr. Sefrina Trisadi, Sp.DV)

Malang, 14 Februari 2025
Notulis

Dokumen ditandatangani secara elektronik. Gunakan Pembaca Tandatangani Elektronik Untuk Verifikasi Dokumen Ini

(Sindy Novenia, S.Pd)

Dokumentasi

